

INFORME DE RESULTADOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Paciente		Solicitante		Muestra	
Nombre	HURTADO MONTAÑO, YAMILETH	Entidad	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S-EPS	Nº estudio	Q-250020092
Sexo	F	Centro	CLINICA IMBANACO	Nº petición	SIAM 92908042025
Edad	46	Médico	BONILLA JARAMILLO JUAN CARLOS	Obtención	29/09/2025
ID	CC31582888	Servicio	CIRUGIA	Registro	29/09/2025
Obs:	FAC LSN-995227531 LSN-995227533 LSM 995227861 LSM 995227862				

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO

INFORME MACROSCÓPICO

(A) - En fresco para biopsia por congelación, rotulado con el nombre de la paciente y marcado "Lóbulo tiroideo izquierdo" se recibe lóbulo tiroideo orientado con dos sedas istmo y una seda polo superior. Pesa 5 gramos y mide 3 x 2.3 x 1.3 cm, el istmo mide 1.7 x 1.4 x 0.7 cm. La superficie es lisa, violácea y elástica. Al corte en el tercio medio e inferior se observa un nódulo que mide 1.4 x 1.3 x 0.9 cm, es blanquecino de bordes parcialmente definidos, en contacto con la cápsula tiroidea de ambas caras. Se marca con tinta negra el borde posterior, con tinta azul el borde anterior y con tinta amarilla el borde de resección del istmo. Se realiza una impronta y se procesa un corte por congelación. Se informa como "POSITIVO PARA MALIGNIDAD". Posteriormente se fija en formalina y se procesa todo en 5 canastillas, rotuladas así:

- A1. Control de congelación.
- A2. Tercio superior.
- A3. Tercio medio.
- A4. Tercio inferior.
- A5. Istmo.

(B) - En un frasco con formalina, rotulado con el nombre de la paciente y marcado "Lóbulo derecho de tiroides" se recibe lóbulo tiroideo sin orientar. Pesa 5 gramos y mide 4.2 x 2.4 x 1.3 cm. La superficie es lisa, violácea y elástica. Al corte entre el tercio medio e inferior se identifica un nódulo, de color pardo y bordes bien definidos que mide 0.7 x 0.7 x 0.5 cm y se encuentra marginal a la cápsula tiroidea de la cara posterior. Se marca con tinta negra el borde posterior y con tinta azul el borde anterior. Se procesa el nódulo completo y cortes representativos del resto del lóbulo en 3 canastillas, rotuladas así:

- B1. Tercio superior.
- B2. Tercio medio.
- B3. Tercio inferior.

(C) - En un frasco con formalina, rotulado con el nombre de la paciente y marcado como "Ganglios centrales cuello izquierdo", se reciben 2 fragmentos de tejido fibroadiposo, son amarillentos y blandos, el mayor mide 2.2 x 1.5 cm. Se disecan algunos nódulos pardos amarillentos y firmes, el mayor mide 0.5 x 0.4 x 0.1 cm. Se procesa todo en 2 canastillas, rotuladas así:

- C1. Nódulos.
- C2. Resto del tejido.

Informe firmado con el software de gestión de procesos de Anatomía patológica **GestPath** con proceso de firma securizado.

INFORME DE RESULTADOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Paciente

Nombre HURTADO MONTAÑO,
YAMILETH

Sexo F

Edad 46

ID CC31582888

Obs: FAC LSN-995227531 LSN-995227533 LSM 995227861 LSM 995227862

Solicitante

Entidad SERVICIO OCCIDENTAL DE
SALUD S.O.S-EPS

Centro CLINICA IMBANACO

Médico BONILLA JARAMILLO JUAN CARLOS

Servicio CIRUGIA

Muestra

Nº estudio Q-250020092

Nº petición SIAM 92908042025

Obtención 29/09/2025

Registro 29/09/2025

Validado por: Hector Fabio Acosta Ñañez

INFORME MICROSCÓPICO

(A) - El nódulo descrito del tercio medio inferior y medio corresponde a una neoplasia maligna de origen epitelial, la cual está caracterizada por una proliferación de estructuras foliculares ligeramente irregulares que están revestidas por células con núcleos aumentados de tamaño, cromatina gruesa asociada a la presencia de hendiduras y pseudoinclusiones. No se identifican mitosis. El tumor es intratiroideo y se encuentra a 0.5mm de los bordes de resección anterior y posterior. El resto del tejido presenta cambios de bocio nodular con oxifilia focal. Ver ptootocolo CAP.

(B) - Se identifican en el tercio medio del lóbulo derecho un adenoma folicular de células oncocíticas que ocupan un área de 4x3mm.sin evidencia de compromiso de la cápsula ni de sus vasos. Se observa además cambios de bocio nodular.

(C) - Se identifica tejido adiposo con representación de cuatro ganglios linfáticos, uno de ellos comprometido focalmente por nidos de células carcinomatosas. El deposito tumoral de mide 2x1mm y no se observa compromiso de la grasa perinodal.

Protocolo CAP. Carcinoma de Tiroides:

Procedimiento: Tiroidectomía total.

Focalidad tumoral: Unifocal.

CARACTERISTICAS TUMORALES

Localización: Tercio medio e inferior del lóbulo izquierdo.

Tamaño tumoral: 1.4x1.3x0.9 cm.

Tipo histológico: Carcinoma papilar variedad folicular.

Tasa mitótica: 0 mitosis por 2 mm².

Necrosis tumoral: No identificada.

Invasión angiolinfática: No identificada.

Invasión perineural: No identificada.

Extensión extratiroidea: No identificada.

Márgenes: Todos los márgenes negativos para malignidad.

Distancia del tumor con el margen anterior: 0.5 mm.

Distancia del tumor con el margen posterior: 0.5 mm

Ganglios linfáticos regionales:

Número total de ganglios linfáticos con carcinoma invasivo: 1

Número total de ganglios linfáticos evaluados: 4.

Nivel ganglionar comprometido: Centrales del cuello izquierdo.

Informe firmado con el software de gestión de procesos de Anatomía patológica **GestPath** con proceso de firma securizado.

INFORME DE RESULTADOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Paciente	Solicitante	Muestra
Nombre HURTADO MONTAÑO, YAMILETH Sexo F Edad 46 ID CC31582888 Obs: FAC LSN-995227531 LSN-995227533 LSM 995227861 LSM 995227862	Entidad SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S-EPS Centro CLINICA IMBANACO Médico BONILLA JARAMILLO JUAN CARLOS Servicio CIRUGIA	Nº estudio Q-250020092 Nº petición SIAM 92908042025 Obtención 29/09/2025 Registro 29/09/2025

Deposito tumoral de mayor tamaño: 2x1 mm.
 Compromiso de la grasa perinodal: No identificada.
 Metástasis a distancia: No aplica.
 pTNM: pT1b, N1a, Mx
 Hallazgos adicionales:
 Bocio multinodular.
 Adenoma folicular (4x3mm) del lóbulo derecho.
 Glándulas paratiroides: No identificadas.

DIAGNÓSTICO

(A) - (B)-(C) TUMOR DEL LÓBULO IZQUIERDO DEL TIROIDES. TIROIDECTOMÍA TOTAL MÁS VACIAMIENTO GANGLIONAR DE LA REGIÓN CENTRAL DEL CUELLO:

CARCINOMA PAPILAR VARIEDAD FOLICULAR.

TAMAÑO TUMORAL 1.4X1.3X0.9 CM.

BORDES DE RESECCIÓN SIN COMPROMISO TUMORAL.

INVASIÓN ANGIOLINFÁTICA Y PERINEURAL: NO IDENTIFICADAS.

BOCIO MULTINODULAR.

ADENOMA FOLICULAR (4X3 MM) DEL LÓBULO DERECHO.

GANGLIOS LINFÁTICOS DE LA REGIÓN CENTRAL DEL CUELLO.
 CARCINOMA PAPILAR METASTÁSICO (1/4).

VER PROTOCOLO CAP.

Codificación CIE-10:

(A)- C73X - TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES

Dr. Harold Daniel Cuello Bueno
 Especialista en patología

Informe firmado con el software de gestión de procesos de Anatomía patológica **GestPath** con proceso de firma securizado.